ההסתדרות הרפואית בישראל
המועצה המדעית
ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION
SCIENTIFIC COUNCIL

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א' 2024

גריאטריה

מס' השאלות בחלק זה:150

1. על פי מחקר ה- Diabetes Prevention Program (DPP) בארה"ב, איזה מהבאים נכון בנוגע לדרכים למניעת סוכרת בגיל המבוגר?

א. ישנה יעילות שווה ל- METFORMIN ולשינוי אורחות חיים בהשוואה לפלצבו
ב. שינוי אורחות חיים יעיל יותר בהשוואה לשימוש ב- METFORMIN
ג. טיפול ב- METFORMIN יעיל יותר בהשוואה לשינוי באורחות החיים
ד. טיפול ב- METFORMIN יעיל יותר במבוגרים לעומת צעירים

2. בן 70, מעשן כבד, ברקע מחלת ריאות חסימתית כרונית קשה וברונכואקטזיות. בשנה האחרונה אשפוזים חוזרים עקב חום, שיעול פרודוקטיבי וקוצר נשימה. איזה טיפול אנטיביוטי מומלץ?

א. INVANZ (ERTAPENEM)
ב. AUGMENTIN (AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID)
ג. ROCEPHINE (CEFTRIAXONE)
ד. CIPROXIN (CIPROFLOXACIN)

3. באיזה מהבאים מתואר הבירור המתאים למטופל בחשד למחלת לב איסכמית יציבה?

א. CT Angio קרדיאלי, בבן 70 עם שינויים ניווניים קשים בברכיים
ב. אקו לב במאמץ, בבן 72 שעבר צנתור כלילי והכנסת סטנט לפני 3 שנים
ג. מבחן מאמץ, בבן 70 עם קוצב לב
ד. מבחן מאמץ, בבן 72 שעבר ניתוח מעקפים לפני 4 שנים

4. בן 79 פנה אחרי שקם בבוקר עם חוסר סימטריה בפנים. מצורפת תמונה (ראה תמונה מספר 1).
אילו ממצאים נוספים צפוי למצוא בבדיקה הגופנית?

א. חולשת יד ימין
ב. דופק לא סדיר
ג. קושי בסגירת עין ימין
ד. שיווי משקל לקוי

5. בן 72, נשוי +2, ארכיטקט שפרש לגמלאות לפני שנתיים.
ללא רקע רפואי רלוונטי, אינו נוטל תרופות.
מגיע להערכה גריאטרית בשל ירידה תפקודית מזה חצי שנה. לדברי המשפחה יש ימים שהוא "מפוזר", לא מגיע לפגישות. לפני כחודש המשטרה עצרה אותו נוסע נגד כיוון התנועה בכביש חד סטרי רחוק ממקום מגוריו והוא הגיב באגרסיביות. מאז בטוח שהמשטרה עוקבת אחריו, ואומר שרואה שוטרים בביתו מסתובבים בלילה. בנוסף אשתו מספרת על הפרעות בשינה, בשנים האחרונות צועק ובועט בזמן השינה.
המשפחה מדווחת שיש ימים שהמטופל מתפקד רגיל ואף עוזר לבנו בעסק המשפחתי.
המטופל מדווח על מצב רוח ירוד מאז היציאה לפנסיה ואומר שמרגיש שאין טעם לחייו.
מספר שמרגיש שגורר רגליים בהליכה ונפל 4 פעמים בחצי שנה אחרונה.
בבדיקת MOCA ציון 19. זיכרון 5/3 מילים, תפקודים ניהוליים וקשב לקויים מאוד.

מה מהבאים מהווה CORE FEATURE לאבחנה של מצבו?

א. דלוזיות פרנואידליות
ב. נפילות חוזרות
ג. דיכאון
ד. פלוקטואציות במצב הקוגניטיבי

6. מה נכון בנוגע לדרכים למניעת סיבוכים קרדיווסקולריים בחולי סוכרת קשישים?

א. לטיפול בסטטינים השפעה פרוגנוסטית מיטיבה תוך שנים בודדות ולכן הוא מומלץ ברוב החולים הסוכרתיים
ב. טיפול באספירין מומלץ כמניעה ראשונית לסיבוכים קרדיווסקולאריים
ג. טיפול בפיברטים מומלץ כאשר ערכי הטריגליצרידים מעל 300 מ"ג/ד"ל
ד. איזון לחץ דם מתחת ל- 160/90 לא הוכח כמשפר פרוגנוזה בחולי סוכרת קשישים

7. איזה מהבאים נכון לגבי הגורמים לחום ממקור לא ידוע (FUO) בגיל המבוגר?

א. פקקת ורידית בגפיים היא אחת מהסיבות ל-FUO במבוגרים
ב. ממאירות מהווה סיבה ל- FUO במבוגרים בכמחצית מהמקרים
ג. המחלה האוטואימונית השכיחה ב- FUO במבוגרים היא SLE
ד. הסיבה השכיחה ביותר ל- FUO במבוגרים היא מחלות אינפלמטוריות

8. בן 78, עם פצע לחץ בעקב מטופל ב- HYDROGEL, שאינו מראה סימני ריפוי מזה 6 שבועות, מתלונן על כאבים חזקים באזור הפצע. בבדיקה סביב הפצע אודם וחום מקומי, ללא חום סיסטמי. ספירת דם ללא לויקוציטוזיס. CRP מוגבר. מצורף צילום הפצע והדמיה (ראה תמונה מספר 2).

מה הטיפול המומלץ?

א. המשך טיפול נוכחי ומעקב קליני
ב. הטריית רקמה נמקית שטחית, ולאחר מכן להשתמש ב- VAC
ג. לקחת דגימת עצם לתרבית, להתחיל טיפול אנטיביוטי רחב טווח תוך ורידי
ד. מעבר לטיפול בחבישות מתקדמות

9. במבוגרים, איזה מהבאים הוא הטיפול לעצירות עם ה-QUALITY OF EVIDENCE הגבוה ביותר?

א. BISACODYL
ב. PSYLLIUM
ג. POLYETHEYLENE GLYCOL
ד. LACTULOSE

10. באיזה מהבאים מתוארת תופעת לוואי המתאימה לתרופה האנטי-פסיכוטיות הרשומה?

א. QUETIAPINE (SEROQUEL) גורם לעוררות
ב. OLANZEPINE (ZYPREXA) גורם לירידה במשקל
ג. CLOZAPINE (LEPONEX) גורם לנויטרופניה
ד. HALOPERIDOL (HALIDOL) גורם לבחילות

11. מהו פרק הזמן המומלץ לטיפול למניעת תסחיף/פקקת ורידית במטופל בשיקום לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך בעקבות שבר ונפילה?

א. לכל תקופת השיקום
ב. במשך שבועיים
ג. עד לניידות מלאה של המטופל לאחר הניתוח
ד. במשך 21 עד 31 ימים לאחר ניתוח

12. מה מהווה מרכיב של המדד הפרוגנוסטי (IPSS) ב- MYELODYSPLASTIC SYNDROME ?

א. נוכחות B SYMPTOMS
ב. ערך של LDH מעל 600
ג. גיל מעל 75
ד. נויטרופילים מתחת ל- 800

13. בן 85, אלכוהוליסט, לאחר נפילה וניתוח לניקוז דימום סוב-דוראלי באי שקט ניכר, מנסה לקפוץ מעל דפנות המיטה, אין היענות לטיפול תרופתי פומי. איזה מהטיפולים התרופתיים הבאים מתאים כקו טיפול ראשון?

א. LORAZEPAM IV (LORIVAN)
ב. DEXMEDETOMIDINE IV (PRECEDEX)
ג. HALIDOL IM
ד. ZYPREXA IM

14. מה נכון לגבי תופעות לוואי של NSAIDS?

א. קיים סיכון קרדיו-ווסקולרי גבוה יותר ב- NSAIDS לא סלקטיבים לעומת NSAIDS סלקטיבים
ב. טיפול בחוסמי משאבות פרוטונים (PPI) תורם להגנה מפני דימום ממערכת העיכול
ג. לצורך הפחתת תופעות לוואי מומלץ להפחית מינון במטופלים עם פינוי קריאטינין < 30 מל/דקה
ד. בחלק מהחולים ניתן לראות ירידת לחץ דם משנית להשפעה משתנת של התרופות

15. בן 76, הופנה למיון עקב ירידה במצב ההכרה. אובחן דימום סובדורלי. הומלץ לבצע ניקוז דחוף. ילדיו דיווחו שאביהם חתם על ייפוי כוח מתמשך ומינה אותם כמיופי כוח.

מה הפעולה הנדרשת כעת?

א. המטופל נמצא במצב אקוטי, לא ברור מה יהיה מצבו הקוגניטיבי בהמשך, על כן אין אפשרות להפעיל את יפויי הכוח המתמשך. יש צורך במינוי אפוטרופוס זמני
ב. יש צורך בחתימה של 3 רופאים בכדי לבצע פעולה דחופה זאת
ג. יש להתחיל בהפעלת יפויי הכוח המתמשך. היות ומדובר במקרה דחוף, ניתן לקבל הסכמה ממיופיי הכוח האמורים להתמנות לקבלת הטיפול הדחוף עוד טרם קבלת האישור מהאפוטרופוס הכללי
ד. המטופל חתם על יפויי כוח מתמשך שאינו רלוונטי למצב זה. במידה ויש ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות – ניתן להפעיל אותו.

16. בן 74. מזה כחודשיים תסמיני דיכאון המשפיעים על התפקוד היומיומי. נבדק במרפאה ובוצע PHQ9. מצ"ב תמונת התוצאה של המבחן (ראה תמונה מספר 3). לפי הממצאים מהי האבחנה המתאימה?

א. Major Depression
ב. Minor Depression
ג. דיסתימיה
ד. ללא דיכאון.

17. בן 87, לאחר ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך, שואל לגבי הפרוגנוזה בעוד שנה. מה מהבאים נכון?

א. הפרעות קוגניטיביות צפויות להשתפר תוך 9-10 חודשים
ב. שיווי משקל צפוי להשתפר תוך 3-4 חודשים
ג. דיכאון צפוי להשתפר תוך כחצי שנה
ד. קשיים בתפקודי הגפיים התחתונות צפויים להשתפר תוך כשנה

18. מה נכון לגבי הגורמים לפרכוס (SEIZURES) בגיל מבוגר?

א. פרכוסים אקוטיים שכיחים יותר בזמן שבץ מוחי דימומי לעומת שבץ איסכמי
ב. דמנציה על רקע אלצהיימר מהווה גורם סיכון להופעת פרכוסים
ג. פרכוסים כרוניים שכיחים יותר לאחר שבץ מוחי איסכמי לעומת שבץ מוחי דימומי
ד. היפרקלמיה מהווה גורם סיכון להופעת פרכוסים

19. איזה מהמקרים הבאים מוגדר כ- CATHETER ASSOCIATED URINARY TRACT INFECTION (CAUTI)?

א. בן 76, חום, צמרמורת, רגישות סופרא-פובית ופנרוז.
ב. בת 73, רגישות במותן, צריבה במתן שתן, קתטר הוצא לפני שבוע.
ג. בן 80, נשא קתטר שתן קבוע, צמיחה של E.COLI בתרבית שתן בכמות של 10^5
ד. בת 84, דליריום, נשאית קתטר שתן קבוע, רגישות סופרא-פובית ושתן מוגלתי.

20. בת 69, ברקע יתר לחץ דם, היצרות מיטרלית ראומטית בדרגה בינונית ואי ספיקת כליות כרונית. אושפזה בשל פרפור פרוזדורים חדש. GFR = 29.

על איזה המלצה מבין ההמלצות הבאות יש להמליץ בעת שחרור המטופלת?

א. טיפול אנטיקואגולנטי ב- ELIQUIS (APIXABAN) במינון של 5 מ״ג פעמיים ביום
ב. טיפול אנטיקואגולנטי ב- XARELTO (RIVAROXABAN) במינון של 15 מ״ג פעם ביום
ג. טיפול אנטיקואגולנטי ב- COUMADIN (WARFARIN) ומעקב ערכי INR
ד. לאור CHA2DS2-VASc פחות מ- 3 מומלץ לא לתת טיפול אנטיקואגולנטי

21. איזו מבין החבישות הבאות מתאימה לטיפול בפצע מפריש בכמות רבה, עמוק עם חללים?

א. חבישת HYDROCOLLOID
ב. חבישת דבש
ג. חבישת HYDROGEL
ד. חבישת ALGINATE

22. מה גורם ל-INTRINSIC ACUTE KIDNEY INJURY?

א. אי ספיקת לב אקוטית משנית ל- MALIGNANT HYPERTENSION
ב. HYPOCALCEMIA
ג. תת תזונה
ד. HEMOLYTIC-UREMIC SYNDROME

23. מה אופייני לכאב ממקור של BURSITIS לעומת ARTHRITIS במרפק?

א. בארתריטיס הכאב הוא חד וממוקד.
ב. באתריטיס הכאב מופק בהנעה אקטיבית אך לא פסיבית.
ג. בבורסיטיס הכאב מופק בהנעה אקטיבית אך לא פסיבית.
ד. בבורסיטיס הכאב הוא עמוק ודיפוזי.

24. באיזה מהמקרים הבאים יתכן ויהיה צורך בהעלאת מינון LEVOTHYROXINE בשל הפרעות בספיגתו?

א. התחלת טיפול ב- CARBAMAZEPINE בשל אירוע פרכוסי
ב. תוספת טיפול בסידן CALCIUM CARBONATE בשל אוסטאופורוזיס
ג. תוספת טיפול בברזל פומי בשל אנמיה
ד. תוספת טיפול ב- ESOMEPRAZOLE בשל גסטריטיס

25. מה מאפיין את ה- BEHAVIORAL VARIANT של FRONTO-TEMPORAL DEMENTIA בשלבים מוקדמים?

א. FLUENT APHASIA
ב. פגיעה בזיכרון
ג. פגיעה בתפקודים ניהוליים
ד. ירידה משמעותית בתוצאת MMSE

26. איזה מהמטופלים הבאים עונה על הגדרת HEALTH CARE-ASSOCIATED PNEUMONIA (HCAP)?

א. מטופל חצי שנה לאחר שחרור מאשפוז ממושך בבית חולים
ב. מטופל המו-דיאליזה
ג. מטופל המתגורר בדיור מוגן
ה. מטופל לאחר טיפול אנטיביוטי ב- AUGMENTIN (AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID) שבועיים טרם קבלתו

27. בן 76, מעשן כבד, סובל מכאבים ברגליים לאחר הליכה של מרחקים קבועים. עבר בירור ואובחן עם PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE.

איזה טיפול מבין הבאים עשוי לשפר את מרחק ההליכה שלו בצורה הטובה ביותר?

א. מנוחה עם הקפדה על הרמת הרגליים למשך שבועיים
ב. הפסקת עישון ותרגילי הליכה מעבר לסף הכאב
ג. שילוב של Aspirin ו- Atorvastatin
ד. טיפול ב- ELIQUIS (APIXABAN) במינון מלא

28. אילו ממצאים צפויים בבדיקת הספירומטריה במבוגרים?

א. FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 sec) לא משתנה עם הגיל
ב. TLC (Total Lung Capacity) יורד עם הגיל
ג. יחס FEV1/FVC יורד עם הגיל
ד. DLCO (Diffusing Capacity of Lung for Carbone Monoxide) לא משתנה עם הגיל

29. איזה אביזר עזר מומלץ למטופל קטוע רגל לפני התאמת פרוטזה?

א. רולטור (ROLLATOR)
ב. הליכון עם 4 גלגלים (4 – WHEELED ROLLING WALKER)
ג. הליכון עם 2 גלגלים (2 – WHEELED ROLLING WALKER)
ד. הליכון סטנדרטי ללא גלגלים (STANDART "PICK-UP" WALKER)

30. איזה מידע תוכל לתת למטופל ומשפחתו בנוגע לטיפול בנזעי חשמל (ECT)?

א. מדובר בטיפול חד פעמי
ב. קיימת פגיעה בזיכרון לטווח קצר שאינה הפיכה
ג. ביותר ממחצית המטופלים צפויה הפוגה (רמיסיה)
ד. קשישים יגיבו פחות טוב לנזעי חשמל ביחס לצעירים

31. בת 60 מגיעה למרפאה בליוויי בעלה. הבעל מתאר כי במהלך חצי השנה האחרונה נצפו שינויים התנהגותיים, הכוללים אכילה ללא שליטה של ממתקים, הערות פוגעניות כלפי זרים, בפעם אחרונה שהגיעה לביקור אצל חברים נכנסה לחדר השינה שלהם והחלה לפתוח מגירות.
ללא מחלות רקע. בדיקה גופנית תקינה. ללא מחשבות שווא או הלוסינציות. מינימנטל 28/30, במבחן שעון סימנה נכון את המספרים אבל לא הצליחה לסמן את השעה עם המחוגים.

מהו הממצא הפתולוגי המאפיין את מצבה של המטופלת?

א. משקעי בתא עמילואיד ו- TAU
ב. משקעי TAU
ג. משקעי Alpha-synuclein
ד. משקעי בתא עמילואיד

32. מהם היתרונות/חסרונות בטיפולים התרופתיים לאוסטאופורוזיס?

א. RALOXIFEM (EVISTA) הוכח כמקטין סיכון לשברי צוואר ירך אך לא לשברי עמוד שדרה
ב. DENUSOMAB (PROLIA) שוקע בעצמות והשפעתו נמשכת גם חודשים לאחר סיום הטיפול
ג. אוסטאו-נקרוזיס של הלסת היא סיבוך שכיח של טיפול ב ZOLDRNIC ACID (ACLASTA).
ד. הטיפול ב- TERIPARATIDE(FORTEO) מוגבל לשנתיים בשל חשש מהתפתחות אוסטאוסרקומה

33. לפי מאמרה של MITCHELL בנושא ADVANCED DEMENTIA, מי מהטופלים הבאים הסובלים מדמנציה, נכנס להגדרה של תוחלת חיים צפויה של פחות מחצי שנה?

א. בן 85, לאחר שבץ, מתהלך עם הליכון, סובל מחולשה ניכרת של היד והפרעות בליעה קשות עם אספירציות וירידה במשקל
ב. בת 89, מיני מנטל 15/30, סובלת מדלקות ריאה חוזרות
ג. בת 79, סיעודית בתפקודה, לא מדברת, לאחר פיילונפריטיס
ד. בן 92, מרותק למיטה לאחר שבר בצוואר הירך, עונה ב"כן" ו"לא" באופן עקבי, סובל מפצע דרגה 4 בעקב

34. מה מאפיין את וירוס ה- SARS-Co Virus 2 (COVID-19)?

א. משתייך למשפחת ה- DNA-Viruses
ב. וירוס שגורם למחלה בבני אדם בשיטת ה- Anthroponotic Transmission
ג. וירוס שחודר למערכת הנשימה דרך רצפטורים של Angiotensin Converting Enzymes -2
ד. ניתן לאתר את הווירוס בדגימות שתן וזרע אך לא בדגימות צואה

35. בת 78, לאחר תיקון שבר פרק ירך. מצורף צילום לאחר הניתוח (ראה תמונה מספר 4). באיזה שבר סביר להניח מדובר?

א. INTER-TROCHANTERIC
ב. SUB-CAPITAL
ג. INTRA-CAPSULAR
ד. FEMUR SHAFT

36. בת 92, ברקע AORTIC STENOSIS. מאושפזת מזה שבועיים בבית חולים בשל דלקת ריאות. עקב אנמיה סימפטומטית קיבלה מנת דם.

בבדיקות המעבדה:

ערכים תקינים	החולה	מדד ויחידות
135-146	138	Na mmol/L
3.5-5.3	4.8	K mmol/L
0.7-1.3	1.9	CREATININE mg/dL
5-25	42	BUN mg/dL
208-378	275	LDH U/L
4.0-11.0	5.8	WBC 10e3/µL
11-17 אישה	8.3	HgB g/dL
80-96	82	MCV fL
150-450	465	Plt 10e3/µL
40-150	22	Iron ng/mL
220-400	126	Tranferrin mg/dL
14-163	648	Ferritin ng/mL
279-996	412	Vitamin B12 pg/mL
5.4-18	6.5	Folic Acid ng/mL

מה הגורם האפשרי לאנמיה והטיפול/בירור המומלץ?

א. מדובר באנמיה מחסר ברזל ומומלץ טיפול בברזל לוריד
ב. בחשד להמוליזה על המסתם התותב כדאי להשלים בדיקת HAPTOGLOBIN
ג. מדובר באנמיה של אי ספיקה כלייתית ומומלץ טיפול באריתרופואטין
ד. בחשד ל- MYELODYSPLASTIC SYNDROME כדאי לבצע בדיקת מח עצם

37. לאיזה מהמנגנונים הבאים נקשרה מחלת פרקינסון?

א. קיפול לא תקין של חלבון TAU ששוקע במוח
ב. אובדן של נוירונים דופמינרגיים ב- SUBSTANTIA NIGRA
ג. אובדן נוירונים כולינרגיים ב- BASAL GANGLIA
ד. הפחתת ייצור של החלבון הסינפטי הנקרא α-SYNUCLEIN

38. בת 78. ברקע יתר לחץ דם, פרפור עליות, החלפת ברך לפני כ- 3 שנים. פנתה למוקד בשל נפילה עם חבלה בברך. ללא ממצא בבדיקתה הגופנית למעט חבלות יבשות, ללא שברים. בתשאול על מנגנון הנפילה מתארת סחרחרות בעת קימה לשירותים מהמיטה לפנות בוקר. בבדיקתה ערנית ומשתפת פעולה, כאובה ברגל, אך נושאת משקל, סימני שפשוף בברך. דופק לא סדיר 65 לדקה, צבע ונשימה תקינים, ל"ד 135/90 בישיבה, 110/80 בעמידה.

מהו הצעד להמשך, בעדיפות ראשונה, על מנת להקטין סיכון לנפילה נוספת?

א. הולטר אק"ג 24 שעות
ב. אקו לב ויעוץ קרדיולוגי
ג. סקירה מחודשת והתאמה של הטיפול התרופתי הקבוע
ד. הפניה לפיזיותרפיה לתרגול מניעת נפילות וחיזוק שרירים

39. איזה מבין ההיגדים הבאים נכון באשר ליעילות הטיפול התרופתי בדיכאון בזקנים?

א. יעילות הטיפול התרופתי בחולים הלוקים בדמנציה מוטלת בספק
ב. יעילות הטיפול בפלצבו זניחה בקרב מטופלים זקנים
ג. יעילות הטיפול התרופתי טובה יותר בקרב המאובחנים עם דיכאון קל לעומת דיכאון חמור
ד. יעילות הטיפול התרופתי טובה יותר ככל שהטיטרציה במינון מהירה יותר

40. מה ההבדלים בין זיהום ויראלי בשפעת INFLUENZA VIRUS לעומת RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV)?

א. לשניהם תסמינים דומים, אך חום אופייני יותר בשפעת
ב. RSV גורר פחות אשפוזים ביחס לשפעת
ג. שפעת היא מחלה עונתית (חורף) וה- RSV לא
ד. טיפול ב- OSELTAMIVIR (TAMIFLU) יעיל בשניהם

41. אילו שינויים באנטומיה של הלב אופייניים לגיל מבוגר?

א. עליה במסה של חדר שמאל
ב. הרחבת העלייה השמאלית
ג. הסטה שמאלה של ציר הלב
ד. הידקקות של הספטום האטריאלי

42. בן 82, עם קרצינומה גרורתית של הערמונית, מוגדר כנוטה למות במצב סופי, עם פצע לחץ דרגה 4 בעכוז, בגודל של 12X11 ס"מ, עומק של 2 ס"מ, עם קטעים נקרוטיים והפרשה מזוהמת בכמות רבה עם ריח אופנסיבי. המשפחה והשכן לחדר מתלוננים על הריח.

מהי הגישה המומלצת במקרה זה להפחתת הריחות?

א. החלפת חבישות פולידין פעמיים ביום
ב. שימוש טופיקלי בתכשיר Metronidazole
ג. ביצוע הטריה כירורגית של הפצע
ד. החלפת חבישה בתדירות גבוהה מהרגיל

43. בת 78, אובחנה כסובלת מ- HEPATOCELLULAR CARCINOMA. מה נכון לגבי האפשרויות הטיפוליות?

א. ניתוח לא הוכח כמשפר פרוגנוזה בקשישים
ב. הסיכונים של transarterial chemoembolization דומים בצעירים ובמבוגרים
ג. טיפול ב- tyrosine kinase inhibitors בקשישים עדיף על ניתוח או transarterial chemoembolization
ד. עקב סיכון מוגבר בכל הטיפולים המוצעים כדאי להתמקד בטיפול פליאטיבי בלבד

44. מהו הטיפול המועדף בגיל המבוגר שמפחית UREMIC PRURITIS במטופל עם אי ספיקת כליות, המטופל בהמודיאליזה ?

א. GABAPENTIN במינון נמוך
ב. CALCILESS (POTASSIUM & SODIUM PHOSPHATE)
ג. CIPRALEX (ESCITALOPRAM)
ד. LYCLEAR CREAM (PERMETHRIN)

45. מה נכון לגבי טיפול ב- HFpEF (HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION) ?

א. EMPAGLIFLOZIN מוריד אשפוזים ותמותה
ב. CANDESRATAN מוריד תמותה אך לא מוריד אשפוזים
ג. חסמי בטא משפרים פרוגנוזה
ד. DIGOXIN מוריד אשפוזים ומוריד תמותה

46. בת 78, סובלת מסוכרת ויתר לחץ דם. פנתה בשל חולשה גוברת וכאב בגפיים תחתונות. כשבועיים טרם פנייתה אובחן שלשול על רקע CAMPYLOBACTER JEJUNI והשלימה טיפול ב- CIPROFLOXACIN .

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

א. נוירופטיה הנגרמה על יד טיפול אנטיביוטי
ב. GUILLAIN-BARRE SYNDROME
ג. MYASTHENIA GRAVIS
ד. נוירופטיה על רקע סוכרת

47. איזו בדיקה יש לבצע בחולה עם RHEOMATOID ARTHRITIS לפני התחלת טיפול ב- ANTI-TNF?

א. אקו לב
ב. תפקודי נשימה
ג. תפקודי קרישה
ד. בדיקת מנטו

48. בן 82, התקבל למיון בשל בלבול חריף. בבדיקות המעבדה: קריאטינין 3 mg/dL, רמת סידן 11.5 mg/dL (תקין – 8.7-10.2 mg/dL), רמת PTH – 12pg/mL (תקין 15-65 pg/mL). איזו מהסיבות הבאות סביר להניח תהיה הגורם למצבו?

א. טיפול ב- DISOTHIAZIDE
ב. היפרפאראתירואידיזם ראשוני
ג. היפרפאראתירואידיזם שלישוני
ד. MULTIPLE MYELOMA

49. מהי הסיבה הכי שכיחה ל- NEPHROTIC SYNDROME בגיל המבוגר?

א. MINIMAL CHANGE DISEASE
ב. DIABETIC NEPHROPATHY
ג. PROLIFERATIVE GLUMERULONEPHRITIS
ד. MEMBRANOUS NEPHROPATHY

50. מה מהבאים אופייני לרעד של מחלת פרקינסון?

א. רעד במנוחה
ב. רעד סימטרי
ג. רעד מתגבר בהושטת הידיים
ד. רעד מתגבר בכתיבה

51. מה נכלל בקריטריונים להשתלת CRT - CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY ?

א. אי ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי EF% = 40
ב. אי ספיקת לב מסוג HFpEF בחומרת NYHA IV
ג. באק"ג משך QRS 120 מילישניות
ד. אי ספיקת לב מסוג HFrEF בחומרת NYHA III

52. איזו מהפעולות הבאות במהלך השיקום אסורה בחולה לאחר החלפה מלאה של ירך בגישה אחורית?

א. ישיבה על כיסא גבוה
ב. ישיבה בפיסוק
ג. ישיבה רגל על רגל
ד. הליכה בדריכה מלאה

53. באיזה מהבאים מתוארת תופעת לוואי המתאימה לתרופה נגד עצירות הרשומה?

א. תמציות SENNA גורמות ל-MELANOSIS COLI
ב. FLEET ENEMA גורם להיפופוספטמיה
ג. PSYLLIUM גורם לטעם מתוק
ד. BISACODYL גורם לריבוי גזים (FLATULENCE)

54. איזה מהבאים הוא אחד הקריטריונים ל-COGNITIVE FRAILTY?

א. דמנציה
ב. מצב תפקודי סיעודי
ג. ירידה קוגניטיבית קלה (MILD COGNITIVE IMPAIRMENT)
ד. דיכאון

55. בת 84, ברקע יתר לחץ דם ואוסטראוארטריטיס. עשתה בדיקת דם שגרתית במרפאה. בבדיקה נמצאה רמת אשלגן 6.4.

מה מהווה סיבה אפשרית להיפרקלמיה באשה זו?

א. PRIMARY HYPERALDOSTERONISM
ב. THROMBOCYTOSIS
ג. HYPOMAGNESEMIA
ד. POLYDYPSIA

56. בן 72 פנה למיון עקב החמרה בקשיי הנשימה בשבוע האחרון, במיוחד בלילות. מציין שיעול והוצאת קצף מהפה בחודש האחרון. ידוע על יתר לחץ דם מזה תקופה ארוכה, סוכרת ואי ספיקת כליות כרונית, עישון של קופסה אחת ליום במשך 20 שנה.
בבדיקתו: חום גוף תקין, 25 נשימות לדקה, לחץ דם 147/98, דופק 110 פעימות לדקה. ריאות: פצפוצים (CREPITATIONS) בבסיסי הריאות דו צדדית, לב: קול נוסף בסוף הדיאסטולה, עמום, בולט יותר בחוד הלב. ללא גודש ווריד הצוואר או בצקות ברגליים.
מה הפתופיזיולוגיה שגרמה למצבו הנוכחי של החולה?

א. הרס של דפנות האלבאולות
ב. בעיה בהרפיית שריר הלב
ג. בעיה בהתכווצות שריר הלב
ד. הסננה דלקתית בריאה

57. מה מאפיין POST-CONCUSSIVE SYNDROME?

א. בחילות והקאות ממושכות
ב. חומרת התסמינים קשורה לחומרת הפגיעה הראשונית
ג. דיכאון, חרדה ושינוים באישיות
ד. תופעה לא שכיחה בקשישים

58. מהו המאפיין הקליני הזהה ב- LATE ONSET RHEUMATOID ARTHRITIS וב- YOUNG ONSET RHEUMATOID ARTHRITIS?

א. בשתי המחלות היארעות גבוהה יותר בנשים לעומת גברים
ב. בשתי המחלות אם RHEUMATOID FACTOR (RF) חיובי המחלה תהיה קשה יותר
ג. בשתי המחלות ברוב החולים RF שלילי
ד. בשתי המחלות יש שכיחות גבוהה של RHEUMATOID NODULES

59. בת 83, פונה בשל תחושת סחרחורת כשעה לאחר ארוחת הצהריים. איזו תופעה פיזיולוגית גורמת לבעיה ממנה סובלת המטופלת?

א. עליה בהחזר הורידי ללב
ב. ירידה בפעילות הפרא-סימפטטית
ג. אפקט וזוקונסטריקטורי של אינסולין על כלי הדם של מערכת העיכול
ד. הצטברות דם במערכת הספלנכנית

60. איזה מהמשפטים הבאים מתאר נכון טיפול בנזק אפשרי לבלוטת התריס משימוש ב- AMIODARONE?

א. במקרה של היפרתירואידיזם קשה המצריך הפסקת AMIODARONE יש צפי לשיפור משמעותי בתפקודי התריס לאחר שבועיים
ב. עלייה ב- TSH שבועיים לאחר התחלת טיפול ב- AMIODARONE מחייבת הפסקה של התרופה
ג. תירוטוקסיקוזיס במנגנון של DESTRUCTIVE THYROIDITIS מגיב לטיפול בסטרואידים
ד. מטופלים עם רקע של מחלת GRAVES נמצאים בסיכון מוגבר להיפותירואידיזם תחת טיפול ב- AMIODARONE ויזדקקו לטיפול בהורמון תירואיד

61. בן 78, אובחן כחולה במחלת פרקינסון, שמתבטאת בעצירות ורעד ביד ימין המשפעים על איכות חייו. באיזו מהתרופות הבאות מומלץ להתחיל?

א. AMANTADINE
ב. PRAMIPEXOLE
ג. LEVODOPA
ד. ENTACAPONE

62. מה הם מאפייני הפנוטיפ של השברירות (FRAILTY) לפי FRIED?

א. חולשה, ירידה לא מכוונת במשקל, מיעוט בפעילות, תשישות
ב. חולשה, איטיות, BMI (body Mass Index) קטן מ-21, מיעוט בפעילות
ג. חולשה, איטיות פסיכומוטורית, ירידה תפקודית, מצב רוח ירוד
ד. איטיות, BMI קטן מ-21 או גבוה מ-30, מיעוט בפעילות, ירידה קוגניטיבית

63. לאיזה מהבאים יש קורלציה גבוהה עם TRAUMATIC BRAIN INJURY?

א. ALZHEIMER'S DISEASE
ב. NORMAL PRESSURE HYDROCEPHALUS
ג. AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
ד. MENINGIOMA

64. בן 77, צלול ועצמאי, הגיע מביתו. ברקע ידוע על Ulcerative Colitis (UC) מזה כ- 15 שנים. המטופל הגיע כדי לשאול לגבי צורך בקולונוסקופיה למעקב. מציין שפעם אחרונה שעשה היה לפני כשנתיים, אז היה תקין.
מה נכון לגבי הצורך במעקב?

א. מאחר והסבירות לממאירות ב- Ulcerative Colitis נמוכה יותר ביחס ל- Chron's Disease, בדיקה חוזרת כל 5 שנים
ב. מאחר וחלפו מעל 10 שנים מתחילת המחלה בדיקה חוזרת אחת ל- 1-3 שנים
ג. מאחר וגילו מעל 75 שנים אין אינדיקציה להמשך מעקב קולונוסקופיה
ד. מאחר והסיכון לממאירות מעל 50%, בדיקה חוזרת כל חצי שנה.

65. בן 85, מתגורר בביתו עם מטפל צמוד בעקבות דמנציה וצורך בהשגחה. מתהלך ללא אביזר עזר. מאושפז בעקבות אירוע מוחי נרחב בטריטוריה של MCA, פלגיה מימין ואפזיה מעורבת.
במהלך האשפוז אירועי אספירציה, טופל באנטיביוטיקה, מוזן דרך זונדה.
בפיזיותרפיה לא מבין הוראות. לא מבצע פקודות פשוטות. מעברים במנוף. משפחתו מבקשת להעבירו למסגרת שיקומית.

מה הגורם השולל התאמת המטופל לשיקום על פי נוהל אמות מידה למתן טיפול שיקומי לקשישים?

א. מגורים קודמים עם מטפל צמוד
ב. הזנה דרך זונדה
ג. צורך בהעברות במנוף
ד. חוסר יכולת לשתף פעולה

66. בהדרכת משפחה לטיפול בהפרעות התנהגות אפשר להיעזר במודל ה- DICE. איזה מהבאים מתאים לחלקי המודל?

א. D- בירור הטיפול התרופתי
ב. I – בדיקת עצירות
ג. C - תיאור הפרעת ההתנהגות
ד. E – הצעת טיפול לא פרמקולוגי

67. מה כוללת גישת ה- SPIKES לבישור בשורה מרה?

א. Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy
ב. Surrounding, Percussion, Innovation, Keep, Examination, Suggestion
ג. Supervision, Pain, Isolation, Kneel, Explanation, Sorry
ד. Suggestion, Pity, Independent, Key, Extraordinary, Sufficient

68. מתי כדאי לבצע בירור בשאלה של DETRUSOR HYPERACTIVITY WITH IMPAIRED CONTRACTILITY?

א. בגברים עם פגיעה נוירולוגית לפני החלטה על PROSTATECTOMY
ב. בנשים שמתלוננות על STRESS URINARY INCONTINENCE
ג. בגברים שנותנים שתן בכמות גדולה 3 פעמים ביום בלבד
ד. בנשים לפני החלטה על טיפול ב- ALPHA ADRENERGIC BLOCKERS

69. בת 85, מגיעה לחדר מיון עקב נפילה וחולשת צד. מצורפת תמונת CT מוח (ראה תמונה מספר 5).
על פי הממצא איזו מהתופעות הבאות מתאימה למיקום הממצא?

א. VISUO-SPATIAL PERCEPTUAL DEFFICIT
ב. ANOSOGNOSIA
ג. APRAXIA
ד. ASTEREOGNOSIS

70. בן 85 הסובל מ- CARCINOMA OF PROSTATE עם גרורות לעצמות. מה נכון לגבי הטיפול התומך?

א. ZOLEDRONIC ACID הוכח כיעיל יותר מביספוספונטים אחרים
ב. DENOSUMAB המשמש לטיפול באוסטאופורוזיס לא יעיל במקרה של גרורות לעצמות
ג. בטיפול בגרורות לעצמות של סרטן הערמונית לא הוכח הבדל ביעילות בין הביספוספונטים השונים
ד. במידה והמטופל סובל מאי ספיקה כלייתית עדיף טיפול ב- PAMIDRONATE על ביספוספונטים אחרים

71. מה המשפט הנכון לגבי גנטיקה של מחלת אלצהיימר?

א. יותר מחצי מהמקרים של YOUNGER-ONSET ALZHEIMER'S DISEASE קשורים למוטציה בגן CARD11 על כרומוזום 7
ב. הגן APOE נמצא על כרומוזום 21 וקשור לסיכון לדמנציה באנשים עם תסמונת דאון
ג. המוטציות בגנים ל- PRESENILIN 1 ו- PRESENILIN 2 נמצאו קשורות ל-LATER ONSET ALZHEIMER'S DISEASE
ד. הגן APOE הוא היחיד שנמצא בקשר ברור עם LATER-ONSET ALZHEIMER'S DISEASE

72. בן 67, יצא לפנסיה לפני 4 חודשים. כחודשיים לאחר יציאתו לפנסיה הופיעו תלונות על קשיי שינה, קשיי ריכוז, פגיעה בזיכרון וקושי בפתרון בעיות. טופל בנוגדי דיכאון. כעבור חודשיים החמרה ניכרת במצבו, אפתיות, תאבון ירוד, שינויים קיצוניים במצב הרוח. בבדיקתו היפר-רפלקסיה, תנועות עיניים לא מתואמות, חוסר שליטה על הסוגרים. בבדיקת MRI אזורים עם קליטה מוגברת (Hyperintensity) .

איזה מהטיפולים הבאים מתאים במצב זה?

א. הפניה לתרופות מחקר על אלצהיימר (כדוגמת DONANEMAB)
ב. שילוב תרופות אנטי-פסיכוטיות
ג. טיפול ב- ECT
ד. להפנות לטיפול תומך פלאיטיבי

73. בת 86, ברקע אוסטיאוארטריטיס, מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם ומחלת עור כרונית מטופלת ב- NSAID'S, ASPIRIN, PREDNISONE, AMLODIPINE, VALSARTAN.
מתלוננת על צרבת ממושכת מזה מספר חודשים ללא תגובה לטיפול ב- PROTON PUMP INHIBITORS (PPI) במינון גבוה.
איזו מהתרופות שמקבלת עשויה לגרום לחולשת LOWER ESOPHAGEAL SPHINCTER (LES)?

א. IBUPROFEN
ב. PREDNISONE
ג. ASPIRIN
ד. AMLODIPINE

74. אילו תסמינים צפויים בהפסקה אקוטית של SEROTONIN SELECTIVE REUPTAKE INHIBITOR) - SSRI (?

א. עליית חום ועלית CPK
ב. יובש בפה וברירות
ג. אצירת שתן
ד. חלומות רעים והפרעות שינה

75. בן 75, דייר בית אבות, מאושפז במחלקה אורתופדית בעקבות שבר בצוואר הירך. מעט ישנוני אך ניתן להעירו לצורך שיחה, לא יודע בן כמה הוא, אינו מתמצא במקום, אינו מתמצא בזמן, במבחן Mini- Cog לא זוכר את כל שלוש המילים, לבקשה לומר את רצף החודשים לאחור מתחיל בדצמבר וממשיך לינואר, פברואר, מרץ.

לפי מבחני הסקר הבאים האם ניתן לאבחן דליריום?

א. CAM חיובי צבר 3 נקודות ומתאים לאבחנת דליריום
ב. 4AT שלילי צבר 3 נקודות ואינו מתאים לאבחנת דליריום
ג. לא ניתן להשלים CAM, חסר מידע ולכן לא ניתן לאבחן דליריום
ד. Ultra-Brief CAM חיובי ולכן מתאים לאבחנת דליריום

76. בן 75, לוקה בפרקינסון מזה 10 שנים, נפילות חוזרות. עד לפני 10 חודשים התגורר לבד בביתו והתהלך עם הליכון גלגלים. עבר למסגרת מחלקה סיעודית לפני כ- 8 חודשים לאחר נפילה ושבר פרק ירך מימין. במחלקה היה רוב הזמן בכיסא גלגלים והתהלך הליכה טיפולית בליווי ועזר במעברים. לפני כחצי שנה נפל בבית האבות ושבר פרק ירך שמאל. במהלך הפוסט-ניתוחי פיתח פצע לחץ דרגה 3 בסקרום ועבר למסגרת סיעוד מורכב. בהדרגה הפצע בשיפור כעת שטחי והוא מתרגל במחלקה הליכה בעזרת הפיזיותרפיסט ועוזר במעברים.

מה המסגרת המתאימה להמשך הטיפול?

א. המטופל שיקומי, ולאחר השיקום יוכל לעבור למסגרת תשושים
ב. המטופל סיעודי מורכב וזקוק להמשך טיפול במסגרת בה נמצא
ג. המטופל שיקומי ומתאים לשיקום במסגרת מחלקה סיעודית
ד. המטופל סיעודי ויש להעבירו למחלקה סיעודית

77. מה נכון לגבי קוצר נשימה DYSPNEA בסוף החיים?

א. חומרת קוצר הנשימה נמצאת בקשר ישיר לרמת ירידת הסטורציה בדם
ב. בחולים ללא היפוקסמיה זרם אויר יעיל להקלה כמו זרם חמצן
ג. מחלות נוירולוגיות גורמות לקוצר נשימה במנגנון של VENTILATION/PERFUSION MISMATCH
ד. שכיח בחולי אי ספיקת לב ו- COPD אך נדיר בחולי דמנציה

78. איזו מהתרופות הבאות היא בעלת האפקט האנטי כולינרגי הנמוך ביותר?

א. METOCLOPRAMIDE (PRAMIN)
ב. ESCITALOPRAM (CIPRALEX)
ג. AMITRIPTYLINE (ELATROL)
ד. PROMETHAZINE (PHENERGAN)

79. מה מאפיין את מחלת Paget של העצמות?

א. מעורבות של עצמות ה- ULNA וה- RADIUS
ב. כאב עצמות שמחמיר בלילה
ג. סיכון להיפוקלצמיה
ד. עמידות יחסית של העצמות לטראומה

80. בן 83, התקבל לאשפוז בשל דלקת ריאות. פיתח דלירים היפראקטיבי ונזקק לטיפול ב- HALOPERIDOL. איזו תופעת לוואי עשויה להופיע עם טיפול זה?

א. פרכוסים
ב. א-גרנולוציטוזיס
ג. יתר לחץ דם
ד. בצקות

81. איזו תרופה מעלה סיכון לדלקת מפרקים עקב שקיעת CALCIUM OXALATE בחולי דיאליזה?

א. ויטמין D
ב. SEVELAMER (RENVELA)
ג. LANTHANUM CARBONATE (PHOSRENOL)
ד. ויטמין C

82. בת 76, עם גורמי סיכון קרדיווסקולריים, פונה לחדר מיון עם חולשת צד ימין, צניחת עפעף שמאל חלקית וכפל ראיה. היכן צפוי שימצא האירוע המוחי?

א. MIDBRAIN ימין
ב. MIDBRAIN שמאל
ג. MEDULLA ימין
ד. MEDULLA שמאל

83. איזה ממצא הדמייתי/ מעבדתי מאפיין דליריום?

א. ELECTROENCEPHALOGRAPHY (EEG) יראה האטה של גלי אלפא
ב. SINGLE-PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY (SPECT) יראה ירידה ממוקמת בזרימת דם לתלמוס
ג. MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) יראה נגעים ממוקמים ב- OCCIPITAL CORTEX
ד. LUMBAR PUNCTURE (LP) יראה ירידה ברמת DOPAMINE בנוזל השדרה

84. במטופל עם מחלה מסכנת חיים, מהי אינדיקציה להזמנת יעוץ פליאטיבי לחולה ביום הראשון לאשפוזו?

א. גיל מעל 90
ב. כאב המצריך טיפול באופיואידים
ג. דליריום
ד. אשפוז עקב אותה הבעיה לפני חודש

85. מה מאפיין CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL)?

א. רובם ממקור של T CELLS
ב. סיכוי טוב לרמיסיה ממושכת בטיפול כימותרפי אגרסיבי
ג. סיכון גבוה ל- LEUKOSTASIS אם יש מעל 100,000 לימפוציטים
ד. סיכון מוגבר ל- COOMB'S POSITIVE HEMOLYTIC ANEMIA

86. בן 83, ללא ירידה קוגניטיבית ידועה. אושפז לאחר חבלת ראש והונשם. במיון נצפתה המטומה סובדורלית נרחבת עם לחץ על החדרים, בוצע ניקוז. הוכנסה זונדה להאכלה ומתן תרופות.
בהמשך המטופל התייצב, חזר להכרה, נגמל מהנשמה, עדיין בדליריום. הוא אינו מסוגל לבלוע ומוזן בזונדה.

בנותיו הביאו הנחיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות שם הינחה לא להאריך חייו באמצעים מלאכותיים - ללא זונדה, ללא דיאליזה, ללא פעולות החייאה.

בנותיו מבקשות להוציא את הזונדה בכדי לכבד את ההנחיות המקדימות. מה נכון לעשות?

א. המטופל אינו מוגדר כנוטה למות, מדובר באירוע חריף אשר גרם לירידה במצבו התפקודי והקוגניטיבי, על כן אין מקום להפעלת הנחיות מקדימות
ב. צריך לעשות את המאמץ הסביר לשכנע את בנותיו שעליו לקבל מזון ונוזלים אף באמצעים מלאכותיים
ג. יש צורך לכבד את ההנחיות המקדימות ולהוציא את הזונדה
ד. מבחינה רפואית הדרך העדיפה למתן נוזלים ומזון היא דרך הפה. ניתן להמשיך להאכילו דרך הפה בכמויות קטנות

87. בן 78. אובחן עם מחלת אלצהיימר והותחל טיפול ב- DONEPAZIL. לאיזו תופעת לוואי ניתן לצפות?

א. הפרעות שינה
ב. דיספפסיה
ג. אצירת שתן
ד. עצירות

88. מה נכון לגבי טיפול בנוגדי טסיות כטיפול מניעתי באירוע קרדיווסקולרי?

א. טיפול ב- ASPIRIN במינון נמוך למניעה ראשונית של אירוע קרדיווסקולרי במטופלים סוכרתיים אינו משפיע על הסיכון ל- Major Bleedings בהשוואה לפלצבו
ב. טיפול ב-PRASUGREL (EFFIENT) מומלץ למטופלים מעל גיל 75 אחרי התערבות קרדיווסקולרית
ג. קיימת אזהרת Black Box Warning לטיפול ב-TIGACRELOR (BRILINTA) במטופלים מעל גיל 85 אחרי התערבות קרדיווסקולרית
ד. הוספת טיפול ב- CLOPIDOGREL (PLAVIX) לטיפול ב-ASPIRIN למטופלים אחרי NSTEMI עשוי להוריד סיבוכים קרדיווסקולריים

89. בת 82. ברקע עודף משקל עם BMI = 32, יתר לחץ דם, אי ספיקת כליות כרונית דרגה IV, עם GFR = 28.
מזה כשנתיים כאבים ברגליים, יותר בברך שמאל, בעיקר בהליכה ובעלית מדרגות.
לאחרונה הכאב מאוד מגביל ולכן מצמצמת יציאות מהבית. נוטלת NUROFEN (IBUPROFEN) לפי הצורך עם הקלה לטווח קצר. קיבלה קורס פיזיותרפיה עם שיפור מינימלי. לא מצליחה לרדת במשקל למרות ניסיונות חוזרים.
בבדיקה – ברך שמאל מעט נפוחה, עם קריפיטציות בתנועה, ללא אודם או חום מקומי.
לחץ דם 145/90. ללא חום סיסטמי.
מה מומלץ?

א. לאור יעילות ה- NUROFEN, מומלץ לנסות מתן זריקת DICLOFENAC (VOLTAREN)
ב. זריקת גלוקו-קורטיקואידים לברך יכולה לתת הקלה בכאב עד חודשיים
ג. ARTHROSCOPIC DEBRIDMENT AND JOINT LAVAGE היא הפעולה הפולשנית המועדפת אם הטיפול התרופתי נכשל
ד. הליכה עם מקל בצד הפגוע תקל את הכאבים ותשפר את היציבות

90. בן 75, דייר מחלקה סיעודית. ברקע דמנציה וסקולרית. מזה כחודש פצע לחץ, כעת בדרגה 3 בטרוכנטר שמאל. משקל 60 ק"ג, BMI 20. בחודש האחרון ירד במשקל כ- 4.5 ק"ג.
הפצע מטופל מקומית בחבישות מתקדמות.
מה מהבאים עשוי לשפר את ריפוי הפצע?

א. ויטמין C 1000 מ"ג ליום
ב. ויטמין E 200 מ"ג ליום
ג. LEUCIN 400 מ"ג ליום
ד. חלבון 90 גר' ליום

91. בן 80, שמור קוגניטיבית ועצמאי בתפקוד, BMI = 30, ברקע מחלת לב איסכמית עם צנתור אחרון לפני כעשור, אי ספיקת כליות עם קריאטנין 1.7 (EGFR של 40 מ"ל/דקה).
טיפול תרופתי קבוע:

INSULIN GLARGINE (LANTUS) 22IU x 1/day

RAMIPRIL 5 mg x 1/d

ATORVASTATIN 40 mg x 1/d

MICROPIRIN 100 mg x 1/d

תוצאות מעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
LDL mg/dL	95	<100
HDL mg/dL	32	>40
Triglycerides mg/dL	101	<150
HBA1C %	8.2	<5.7
Albumin/Creatinine mg/g	300	<30

מה מבין השינויים התרופתיים הבאים הוא בעל אפקט פרוגנוסטי חיובי למטופל?

א. הפסקת ה- ATORVASTATIN מכיוון שמדובר במטופל מעל גיל 75
ב. התחלת טיפול ב-EMPAGLIFLOZIN 10 mg (JARDIANCE)
ג. הוספת אינסולין קצר טווח עם הארוחות
ד. הוספת טיפול ב- CLOPIDOGREL 75 mg

השאלות 92-100 מוצגות על דרך השלילה (לא נכון, לא גורם, פרט ל...), שימו לב!

92. איזה מהבאים <u>לא גורם</u> ל- ACUTE URINARY INCONTINENCE?

א. היפוקלצמיה
ב. היפרגליקמיה
ג. טיפול ב- FUROSEMIDE
ד. אבני צואה

93. בת 82, ברקע סוכרת עם נוירופתיה פריפרית, יתר לחץ דם ודיכאון. מקבלת טיפול ב- GLUCOMIN, RAMIPRIL, DISOTHIAZIDE, ASPIRIN, CYMBALTA. התקבלה למיון לאחר נפילה. בבדיקתה איוושה מעל קרוטיד ימין.
איזה מהגורמים, המתוארים במקרה של המטופלת, <u>לא הוכח</u> כגורם סיכון גבוה לנפילות במחקרים באיכות גבוהה?

א. היצרות עורק הקרוטיס
ב. נוירופתיה פריפרית
ג. הטיפול התרופתי שלה
ד. דיכאון

94. איזו מהתרופות הבאות <u>לא מתאימה</u> להתחלת טיפול בהפרעות שינה על רקע RESTLESS LEG SYNDROM?

א. TRAMADOL
ב. PREGABALIN (LYRICA)
ג. CARBIDOPA/LEVODOPA (SINEMET)
ד. MAGNESIUM

95. איזה מהסימפטומים הבאים <u>לא ישתפר</u> עם הורדת מינון הטיפול התרופתי לפרקינסון?

א. הפרעות שינה
ב. הזיות
ג. דיכאון
ד. פסיכוזה

96. איזה מהבאים <u>לא מהווה</u> טיפול מקובל לתסמונת GUILLAIN-BARRE?

א. PLASMAPHERESIS (PLEX)
ב. IV IMMUNOGLOBULINS (IVIG)
ג. סטרואידים
ד. טיפול שיקומי

97. הטריית פצעים מוכרת כמרכיב חשוב בטיפול במיטת הפצע. מה מהבאים מהווה <u>התווית נגד</u> לביצועה?

א. הטרייה לצורך הפחתה בריח או כדי לנקז כיסי מוגלה מהפצע

ב. הטרייה של קרוסטה שחורה (ESCHAR) בעקב בחולה עם מחלת כלי דם היקפית

ג. הטרייה כירורגית לאזור נמקי נרחב

ד. הטרייה של פצע בעכוז המכוסה בחלקו בשכבת SLOUGH

98. מה <u>לא נכון</u> בנוגע לתסמינים או הפרעות נוירופסיכיאטריות במצב של דמנציה?

א. תסמינים נוירופסיכאטרים מגיבים היטב לטיפול בתרופות אנטי-פסיכוטיות
ב. הפרעות נוירופסיכאטריות הן הסיבה העיקרית להכנסת מטופלים הלוקים בדמנציה למוסדות
ג. הפרעות נוירופסיכאטריות יכולות להימצא בכל שלבי הדמנציה, אפילו לפני שמאובחנת ירידה קוגניטיבית
ד. הפרעות נוירופסיכאטריות מזרזות התקדמות של דמנציה ממצב קל למצב קשה

99. איזה מהבאים <u>לא נכלל</u> בשינויים הקוגניטיביים של זקנה רגילה?

א. פגיעה ביכולת התחבירית
ב. פגיעה בשליפת מילים ושטף
ג. ירידה במהירות עיבוד מידע
ד. ירידה ביכולת הלימוד ושימוש במידע חדש

100. שימוש ממושך ב- INHALED CORTICOSTEROIDS בחולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) עלול לגרום לכל התופעות הבאות <u>פרט ל-</u>

א. עליה בשכיחות דלקות ריאה
ב. צרידות
ג. דימום מערכת עיכול עליונה
ד. נפילות

101. מה מאפיין SPINAL CORD COMPRESSION?

א. המקום השכיח ביותר הוא בעמוד השדרה התורקלי
ב. הסיבה השכיחה היא גרורה ממקור של המעי הגס
ג. בדרך כלל הביטוי הראשון הוא חולשת שרירים דיסטלית למקום הנזק
ד. הכאב מוחמר בישיבה

102. מה המשפט המתאר נכונה בירור של פוליציטמיה?

א. אריתרופואטין נמוך מכוון להרעלת CO.
ב. אריתרופואטין גבוה מכוון ל- POLYCYTHEMIA VERA
ג. אריתרופואטין גבוה מחייב בירור לגידול מפריש אריתרופואטין
ד. ברוב האנשים עם אריתרופואטין נמוך תימצא מוטציה ב- JAK2

103. בן 78 , ברקע יתר לחץ דם, דיכאון וסוכרת עבר בירור להפרעות שינה ואובחן כסובל מ- Obstructive Sleep Apnea ברמה חמורה. ניסה טיפול ב- CPAP שהופסק אחרי שבוע עקב אי סבילות.
מה ניתן להציע לו?

א. התייעצות מומחה להתאמת ה- CPAP
ב. טיפול תרופתי ב- ZOPICLONE (NOCTURNO)
ג. טיפול תרופתי ב- CLONAZEPAM (CLONEX)
ד. יעוץ אף אוזן גרון בשאלה של ניתוח

104. באיזה מהבאים מתואר ממצא בבדיקה הגופנית המתאים לבעיה המסתמית המפורטת?

א. PULSUS PARADOXUS ב- AORTIC STENOSIS
ב. לחץ דם ביד גבוה מלחץ הדם ברגל ב- AORTIC INSUFFICIENCY
ג. צרידות בקול ב- MITRAL STENOSIS
ד. PULSUS PARVUS et TARDUS ב- MITRAL INSUFFICIENCY

105. לאיזה מהגידולים הבאים יש סיכוי לריפוי מלא עם טיפול כימותרפי בלבד?

א. BLADDER CARCINOMA
ב. SMALL CELL LUNG CARCINOMA
ג. GASTRIC CARCINOMA
ד. PROSTATE CARCINOMA

106. בת 78 התקבלה למיון עם ST-ELEVATION MI (STEMI). תפקוד כלייתי תקין. כמה זמן רמת הטרופונין עשויה להיות גבוהה בדם?

א. 48 שעות
ב. עד 5 ימים
ג. 7-10 ימים
ד. 14 ימים

107. באיזה מהבאים מתואר ממצא בתפליט הפלאורלי המתאים למחלה המפורטת?

א. בשחפת יחס חלבון פלאורה/סרום 0.3
ב. בממאירות רמת גלוקוז 50 גרם/ד"ל
ג. בצירוזיס יחס LDH פלאורה/סרום 0.8
ד. בראומטואיד ארתריטיס ערך LDH בנוזל הפלאורלי 150 וערכים תקינים בסרום 208-378.

108. באיזה מהבאים מתואר טיפול שיעילותו הוכחה למניעת הזיהום בחולי סרטן המקבלים את הטיפול המפורט?

א. TRIMETOPRIM/SULPHAMETOXAZOL למניעת PNEUMOCYSTIS CARINII במטופלים המקבלים טיפול ממושך בסטרואידים
ב. IVIG אחת לחודש למניעת ספסיס בחולי ACUTE MYELOID LEUKEMIA לאחר טיפול כימותרפי
ג. PAXLOVID למניעת קורונה בחולי סרטן ריאה לאחר ניתוח
ד. "בידוד הגנתי" עם חלוק, כפפות ומסיכה לחולים נויטרופנים

109. בן 70, פנה בשל שלשול מזה מספר חודשים, צואה רכה 3-4 פעמים ביום. ללא שינוי בטיפול התרופתי, ללא דם בצואה. לא עבר מעולם בירור אנדוסקופי. מה נכון לגבי הבירור והטיפול במטופל זה?

א. חסר לקטז (LACTASE DEFICIENCY) היא סיבה שכיחה לכן יש להמליץ על ניסיון הימנעות ממוצרי חלב
ב. INFLAMMATORY BOWEL DISEASE היא הסיבה הסבירה ולכן יש להתחיל טיפול במינון נמוך של SULFASALAZINE ולתאם תור לבירור אנדוסקופי
ג. IRRITABLE BOWEL SYNDROME היא הסיבה הסבירה ולכן יש להתחיל טיפול ב- SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS
ד. זיהום ממושך ב- SALMONELLA הוא הסיבה הסבירה ולכן יש להתחיל טיפול ב- CIPROXIN

110. איזה מהבאים הוא ממצא אופייני בבדיקות הדם של אדם עם טחול מוגדל והיפרספלניזם?

א. HOWELL-JOLLY BODIES באריתרוציטים
ב. לימפוציטוזיס
ג. טרומבוציטופניה
ד. אנאיזוציטוזיס

111. איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי נזק מאוחר של טיפולים לסרטן?

א. נזק לאחר קרינה למוח מופיע לאחר מספר ימים והוא בדרך כלל פרוגרסיבי
ב. טיפול ב- BLEOMYCIN מעלה סיכון ל- PULMONARY FIBROSIS
ג. נזק מיוקרדיאלי של ADRIAMYCIN מופיע כחודש לאחר הטיפול הראשון ומשתפר עם סיום הכימותרפיה
ד. הגידול המשני השכיח לאחר טיפול קרינתי הוא ACUTE MYELOID LEUKEMIA

112. מה מהבאים נכון לגבי הנוגדן RF (REHUMATOID FACTOR)?

א. בעל סגוליות (ספציפיות) דומה ל- ANTI-CCP
ב. בעל סגוליות (ספציפיות) נמוכה ולא טובה לאבחון RHEUMATOID ARTHRITIS
ג. נמצא בטיטרים גבוהים במחלות זיהומיות כגון שחפת והפטיטיס זיהומית
ד. ממצא נפוץ באוכלוסייה בריאה זקנה

113. בת 75, ברקע סוכרת, יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית. פונה בשל כאבים בחזה בעלי אופי לא טיפוסי. בבדיקה גופנית: איוושה הולו-סיסטולית מקרינה לאקסילה ופיצול רחב של S2. באקו לב: הרחבה של העליות.

מה עוד צפוי למצוא בבדיקה הגופנית?

א. קול S4
ב. Opening Snap
ג. Pulsus parvus et tardus
ד. קול ראשון מוחלש

114. איזו מהתופעות הבאות אינה חלק מ- TUMOR LYSIS SYNDROME?

א. ACUTE RENAL FAILURE
ב. HYPERPHOSPHATEMIA
ג. HYPOKALEMIA
ד. ELEVAED URIC ACID

115. איזו אוושה מתגברת בזמן וולסלבה?

א. AS
ב. MS
ג. TR
ד. MVP

116. בת 85 עשתה בדיקות דם לפני ניתוח אלקטיבי. בעברה 3 לידות ו- TONSILLECTOMY בילדות ללא דימום חריג. בבדיקות המעבדה נמצא:

PT- 12 sec (תקין 11-13.5)

INR - 0.95

PTT- 45 sec (תקין 25-35)

מה האבחנה הסבירה ביותר?

א. FACTOR V LEIDEN HETEROZYGOTE
ב. FACTOR XII DEFICIENCY
ג. המופיליה A
ד. FACTOR VII DEFICIENCY

117.בן 72, פנה בשל שיעול דמי מזה יומיים. בבדיקתו חום פומי 37.8 מעלות צלזיוס, צפצופים דו צדדיים. צילום חזה ללא ממצא. מה הבדיקה הבאה שנדרש לבצע?

א. פאנל וירוסים נשימתיים
ב. CT חזה
ג. ברונכוסקופיה
ד. ליחה לשחפת

118.בת 83, ברקע ידוע על שחמת, ככל הנראה על רקע אלכוהולי, עדיין צורכת לסירוגין אלכוהול. אושפזה בשל כאבי בטן ואירועי הקאה לאחר שתיית בקבוק שלם של אלכוהול. שוללת שינוי בהרגלי יציאות, שוללת שינוי בטיפול תרופתי. בבדיקות הדם הפרעה משמעותית באנזימי הכבד. בוצע US בטן, ללא עדות למיימת. כיצד נכון להתקדם בבירור ובטיפול?

א. לצורך החלטה לגבי טיפול בסטרואידים סיסטמיים, יש לקחת תפקודי קרישה ורמת בילירובין
ב. במידה ו- MCV מעל 100, מומלץ על עירוי נוזלים ותוספת ויטמין B12 וחומצה פולית
ג. במידה ו- DISCRIMINANT FUNCTION פחות מ- 32, יש להתחיל טיפול ב- N-ACETYLCYSTEINE תוך ורידי
ד. מומלץ טיפול במעכבי TUMOR NECROSIS FACTOR כגון INFLIXIMAB או ETANRACEPT

119.מה מאפיין זיהומים במטופלים לאחר כריתת טחול?

א. סיכון מוגבר לדלקת ריאות משנית ל- PNEUMOCYSTIS CARINII
ב. הסיכון לזיהומים עולה עם הזמן
ג. סיכון מוגבר לזיהומים ויראליים
ד. חלק מהזיהומים הם פולימיקרוביאלים

120. מהי הסיבה הנפוצה ביותר לתפליט פלאורלי אקסודטיבי?

א. דלקת ריאות
ב. ראומטואיד ארתריטיס
ג. תסחיף ריאתי
ד. ממאירות

121. בת 71, פנתה למיון לאחר 15 שעות מתחילת כאבים בחזה. בתרשים אק"ג הודגמו עליות ST בקיר קידמי. בקבלתה ללא כאבים בחזה. הוחלט על טיפול שמרני. שבוע לאחר מכן במהלך אשפוז הופיעה חולשה בפלג גוף שמאל. עברה CT מח שדימת אוטם מוחי איסכמי בעורק ה- MID.CEREBRAL ARTERY (MCA). איזה מהבאים נכון?

א. השלמת בירור על ידי דופלר עורק צוואר היא הבדיקה החשובה ביותר
ב. השלמת בירור על ידי אקו לב היא הבדיקה החשובה ביותר
ג. אין צורך בביצוע CT ראש לשלילת דימום מוחי
ד. יש להתחיל טיפול אנטיקואגולנטי ולהמשיך לכל החיים.

122. איזה מהבאים נכלל בהגדרה של INFLAMATION OF UNKNOWN ORIGIN (IUO) ?

א. עליות חוזרות ב- CRP במהלך שבועיים לפחות
ב. חולה הסובל מדיכוי חיסוני
ג. 3 תרביות דם שליליות
ד. CT בטן תקין

123. בן 75, אושפז עקב ST-ELEVATION MI (STEMI). עבר PERCUTANEUS CORONARY INTERVENTION (PCI) תוך שעה עם סטנט לעורק חסום ללא סיבוכים. בשחרור מצבו יציב וללא כאבים בחזה מה ההנחיות שיש לתת לו בנוגע לפעילות לאחר השחרור?

א. מבחן מאמץ אחרי חצי שנה
ב. פעילות מינית אחרי שלושה חודשים
ג. הליכות קצרות בשבועיים הראשונים
ד. חזרה לעבודה לאחר חודשיים

124. בן 80, מתלונן על קוצר נשימה שמחמיר במאמץ מזה 10 חודשים. ברקע עישון כבד שהפסיק לפני 15 שנים. בבדיקתו פצפוצים עדינים בבסיסי הריאות. מצורפת בדיקת HRCT תמונה מספר 6. אין ממצאים של מחלה אוטואימונית או גורמים הקשורים לטיפול תרופתי. איזה טיפול מתאים למטופל?

א. AZATHIOPRINE
ב. PREDNISONE
ג. השתלת ריאות
ד. NINTEDANIB

125. בת 67, עלתה מאוקראינה לפני שבוע, אושפזה לבירור הפרעה באנזימי כבד, עם הפרעה כולסטטית משמעותית. הבדיקות נלקחו בקהילה לבירור גרד. לדבריה שותה קצת אלכוהול רק באירועים חברתיים, אחת לשבועיים-שלושה. ב- US בטן כבד עם חשד למראה שחמתי. בבדיקות הדם:

רמת אלכוהול בדם תקינה .

Antimitochondrial Antibodies (AMA) חיובית

Antinuclear Antibodies (ANA) שלילית

Anti-Smooth Muscle Antibodies (ASMA) שלילית

הפטיטיס ויראלית שלילית.

מה נכון לגבי תהליך הבירור והאבחון?

א. שחמת על רקע אלכוהולי לנוכח מוצא המטופלת ואנמנזה
ב. Primary Biliary Cholangitis - ניתן להשלים ביופסיית כבד
ג. Autoimmune Hepatitis - יש להתחיל טיפול בסטרואידים בהקדם
ד. Primary Sclerosing Cholangitis (PSC) - מומלץ לבצע Magnetic Resonance Cholangiopancreatography (MRCP)

126. באיזה מהמקרים הבאים של היפונתרמיה צפוי למצוא ריכוז נתרן נמוך בשתן?

א. בת 90, מתגוררת לבד, ללא טיפול תרופתי קבוע. בבדיקה: אאוולמית וקחכטית
ב. בן 69, עם אי ספיקת לב שהחל טיפול בפוסיד פומי לפני כשבוע. בבדיקה: בצקת בשוקיים
ג. בת 72, עם ממאירות ריאה, תחת טיפול כימותרפי. בבדיקה: אאוולמית
ד. בן 75, היפותירואידיזם לא מטופל, מעורפל הכרה. בבדיקה: בצקת בשוקיים

127. בן 72, פנה בשל חום עד 38.2 מזה יומיים ואובחן עם אנדוקרדיטיס של מסתם אאורטלי מכני שהושתל לפני שנתיים. תרביות הדם בעבודה.

מהו הטיפול האמפירי המתאים עד לקבלת תוצאות התרבית?

א. GENTAMICIN + AMPICILLIN
ב. GENTAMICIN + PENECILLIN
ג. DOXICILLIN + CEFEPIME
ד. VANCOMYCIN + CEFTRIAXONE

128. באיזה מנגנון עשוי VANCOMYCIN לגרום לאי ספיקת כליות חריפה?

א. חסימה אינטרטובולרית על ידי קריסטלים של ונקומיצין
ב. הצטברות בקורטקס הרנלי
ג. וזוקונסטריקציה רנלית
ד. מיקרואנגיופתיה טרומבוטית

129. בן 78, פנה למיון בשל כאב עז בבוהן רגל שמאל. ממצאי הבדיקה מופיעים בתמונה (ראה תמונה מספר 7).
במעבדה: רמת חומצה אורית מעט מוגברת, קריאטינין 1.7mg/dL,
CCT מחושב – 42 ml/min.
מהו הטיפול המועדף בשלב זה?

א. COLCHICINE במינון 0.5 מ"ג- 1 מ"ג פעם ביום
ב. ALLORIL במינון 300 מ"ג פעם ביום
ג. NAPROXEN (NAXYN) במינון 500 מ"ג פעמיים ביום
ד. PROBENECID במינון 250 מ"ג פעמיים ביום

130. באיזו הפרעה במאזן חומצה-בסיס נצפה למצוא רמות גבוהות של כלור בדם?

א. בסיסת נשימתית
ב. חמצת נשימתית
ג. בסיסת מטבולית
ד. חמצת מטבולית

131. בן 71, עם רקע של פרפור עליות, יתר לחץ דם וסוכרת, מטופל תרופתית. פונה למיון בשל אירוע חד של סחרחורת סיבובית. מצורף אק"ג (ראה תמונה מספר 8).

איזה ממצא סביר שימצא במטופל זה?

א. רמת דיגוקסין מוגברת בדם
ב. רמת אשלגן מוגברת בדם
ג. רמת סידן מוגברת בדם
ד. דימום מוחי

132. איזה מפרק נפגע בשכיחות הגבוהה ביותר ב- CALCIUM PYROPHOSPHATE DEPOSITION DISEASE (CPPD)?

א. מפרק בוהן ראשונה
ב. ברך
ג. שורש כף היד
ד. כתף

133. מה נכון לגבי הטיפול ב- DEXAMETHASONE במנינגיטיס חיידקית?

א. יש לתת את הטיפול כ- 20 דקות לפני מתן הטיפול האנטיביוטי
ב. ניתן חד פעמית בסמוך למתן האנטיביוטיקה
ג. טיפול זה מעלה את חדירות ה-BBB ל- VANCOMYCIN
ד. הטיפול מפחית תמותה אך לא מפחית את הפגיעה בשמיעה

134. בן 77, פונה למיון בשל חום סוב-פיבריל 37.8 וכאבי גב חדשים. בבדיקה חולשה בגפיים תחתונות וירידה בתחושה. בתרביות הדם שנלקחו צמיחה של PSEUDOMONAS AERUGINOSA.
מה יהיה הטיפול האנטיביוטי המתאים בשלב ראשון?

א. PO CIPROFLOXACIN
ב. IV CIPROFLOXACIN
ג. IV TAZOCIN + AMIKACIN
ד. IV CEFTAZIDIME (FORTUM)

135.במי מהחולים הבאים יאובחן בוודאות אנדוקרדיטיס?

א. חולה עם חום, אירוע מוחי ושתי תרביות דם חיוביות ל- STREP.VIRIDANCE
ב. חולה עם חום, לאחר תיקון היצרות מסתם אאורטלי, שתי תרביות דם חיוביות ל- STAP.COAGULASE NEGATIVE
ג. חולה עם מסתם מיטרלי תותב, זוג תרביות דם חיוביות ל- ENTEROCOCCI, וחום מזה שבוע
ד. חולה ללא חום עם אי ספיקה מיטרלית חדשה בבדיקת אקו ותרבית דם חיובית אחת ל- COXIELLA BURNETII

136.בן 75, מאושפז בטיפול נמרץ בשל פנקריאטיטיס קשה ושוק.
במדידת הפרמטרים, איזה מהבאים אופייני לשוק ממקור של פנקריאטיטיס?

א. CARDIAC OUTPUT גבוה
ב. CENTRAL VENOUS PRESSURE גבוה
ג. SYSTEMIC VASCULAR RESISTANCE גבוה
ד. PULMONARY CAPILLARY WEDGE PRESSURE גבוה

137.בת 78, לאחר טיפול בהקרנות לסרטן בלוטת התריס. פונה בשל חולשה כללית
ונימולים בקצות האצבעות. בזמן מדידת לחץ דם אצל האחות מופיע CARPAL SPASM.
מה השינוי הצפוי באק"ג?

א. הופעת גלי U
ב. חידוד גלי T
ג. הארכת QT
ד. היפוך גלי T בכל הלידים.

138.בת 74. לפני כחודש, בשל כאבי גב עזים, נטלה טיפול ב- IBUPROFEN במשך שבועיים וקיבלה שתי זריקות VOLTAREN תוך שרירית. פונה כעת בשל בצקות חדשות. ללא קוצר נשימה.
בבדיקתה קולות לב סדירים, ללא אוושות, ללא עלית JUGULAR VENOUS PRESSURE (JVP), כניסת אויר טובה דו צדדית, ללא קרפיטציות או חרחורים, ללא הגדלת כבד או טחול. בצקת בגפיים תחתונות עד גובה השוקיים וסביב העיניים.

בבדיקות הדם:

ערכים תקינים	החולה	מדד ויחידות
0.7-1.3	2.8	CREATININE mg/dL
5-25	24	BUN mg/dL
3.5-5.1	4.7	K mmol/L
136-145	137	Na mmol/L
3.2-4.6	2.1	ALBUMIN g/dL
5-34	31	AST (GOT) u/l
0-55	35	ALT (GPT) u/l
<100	200	LDL mg/dL
>40	32	HDL mg/dL
<150	375	CHOLESTEROL mg/dL

בבדיקת שתן בסטיק:

RBC (++)

WBC (-)

PROTEIN (+++)

מה השלב הבא בבירור?

א. אקו לב
ב. US כבד
ג. ביופסית כליות
ד. איסוף שתן לחלבון

139. במטופל עם שוק ספטי, איזו מהפעולות הבאות יש לבצע על פי ההנחיות הקליניות?

א. מתן HYDROCORTISONE במינון 100 מ"ג תוך שעה
ב. מתן נוזלים/קריסטלואידים תוך 3 שעות
ג. מתן מנת דם אם המוגלובין יורד ל- 8 גרם/ד"ל
ד. מתן טיפול באינסולין אם יש מדידת סוכר אחת של 200 מ"ג/ד"ל

140. במטופל עם חשד לאנצפליטיס על רקע HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) איזה מהמשפטים הבאים נכון בנוגע לבדיקות לצורך האבחנה?

א. ב- MRI נראה שינויים דיפוזיים בחומר הלבן
ב. PCR עשוי להיות שלילי ב- 72 השעות הראשונות
ג. סרולוגיה חיובית בדם מסייעת באבחון זיהום זה
ד. תרבית CSF שלילית ל- HSV שוללת זיהום זה

141. בת 85, מאושפזת בשיקום לאחר תיקון שבר ירך. ביום החמישי לאשפוז מפתחת סינקופה.
בבדיקת סימנים חיוניים: 23 נשימות לדקה, דופק 125 לדקה, לחץ דם 40/80, סטורציה 85%.
בבדיקתה הגופנית: כניסת אויר מופחתת לבסיסי הריאות עם קריפיטציות מעל, JVP מוגבר, פריפריה קרה.

מה יהיה השלב הבא?

א. שלילת ADRENAL INSUFFICIENCY
ב. חיפוש מקור זיהום
ג. חיפוש מקור דימום
ד. שלילת איסכמיה קרדיאלית

142. איזו מהתרופות הבאות לטיפול בבחילות והקאות פועלת במנגנון המעודד תנועתיות של המעי?

א. MEOCLOPRAMIDE (PRAMIN)
ב. ONDANSETRON (ZOFRAN)
ג. SCOPOLAMINE
ד. GABAPENTIN

143. בת 88, אושפזה עקב סינקופה. ברקע: יתר לחץ דם, דיכאון, דמנציה ו- ATRIAL FIBRILLATION. תרופות קבועות – Mirtazapine, Amiodarone, Apixaban, Risperidone ו- Amlodipine . בשבוע האחרון סבלה מזיהום בדרכי השתן וקיבלה אנטיביוטיקה.
בדיקת אק"ג מצורפת. ראה תמונה מספר 9.

מה סביר שהיתה האנטיביוטיקה שקיבלה לאחרונה?

א. CIPROFLOXACIN
ב. TRIMETHOPRIM + SULFAMETHOXAZOLE
ג. AMOXICILLIN + CLAVULANATE
ד. CEFUROXIME

144. איזה מהבאים הוא ממצא אופייני בניקור מותני (LUMBAR PUNCTURE) במנינגיטיס חיידקי?

א. GLUCOSE מתחת ל- 80mg/dL
ב. RED BLOOD CELLS מעל ל- 50 µL
ג. לחץ פתיחה מתחת ל- 50 mmH_2O
ד. חלבון מעל 45 mg/dL

145. מה המשפט הנכון לגבי התייחסות לערכי אשלגן במטופלים עם אי ספיקה כלייתית כרונית?

א. קיימת קונטראינדיקציה למתן ACE INHIBITORS בחולים אלה עקב סיכון להיפרקלמיה
ב. היפרקלמיה שלא מגיבה לטיפול תרופתי היא אינדיקציה לדיאליזה
ג. התועלת של דיאטה דלת אשלגן לטיפול בהיפרקלמיה היא מינורית
ד. renal tubular acidosis גורם להיפרקלמיה רק בשילוב עם פגיעה גלומרולית מתקדמת

146. בן 84, עם רקע של סוכרת, מחלת לב איסכמית ואי ספיקת לב. אושפז עקב דלקת ריאות וטופל ב- CEFTRIAXONE. לאחר 3 ימי טיפול עקב חוסר שיפור קליני עבר צילום ונמצא נוזל פלאורלי. עבר ניקור אבחנתי בו נמצא PH-7.1 וגלוקוז 40.

מה השלב הבא בניהול המקרה?

א. שידרוג הטיפול האנטיביוטי ל- Piperacillin/Tazobactam
ב. ניקור חוזר להוצאת כל הנוזל
ג. מתן IV FUSID
ד. ביצוע CT אנגיו

147. בת 74, עם רקע של יתר לחץ דם והיפרליפידמיה פנתה למחלקה לרפואה דחופה עקב כאבים בחזה.
סימנים חיוניים: לחץ דם 45/78, דופק 104, סטורציה 97%. בבדיקה: ריאות נקיות, גודש ורידי צוואר ניכר, רגישות בבטן ימנית עליונה.
בדיקת אק"ג מצורפת. ראה תמונה מספר 10.

מה הבדיקה הראשונה שתוכל לקדם את האבחנה האפשרית?

א. אולטרסאונד של הכבד
ב. K בדם
ג. אק"ג ימני
ד. CT אנגיו

148. בן 75, מתלונן על כאב גב מזה חודש. הכאב מקרין לרגל ימין, מוחמר בהליכה.
בבדיקה גופנית יש רגישות באזור חוליות מותניות.

מה מהווה גורם סיכון לפגיעה סטרוקטולית משמעותית במטופל זה?

א. גיל
ב. הקרנה לרגל
ג. החמרה בהליכה
ד. רגישות מקומית בבדיקה

שתי השאלות הבאות כתובות על דרך השלילה (לא גורם), שימו לב!

149. איזו מהתרופות הבאות <u>לא גורמת</u> לנויטרופניה?

א. LITHIUM (LICARBIUM)
ב. CHLORAMPHENICOL (SYNTHOMYCIN)
ג. CLOZAPINE (LEPONEX)
ד. METHIMAZOLE (MERCAPTIZOLE)

150. ניתוח מעקפים עשוי לגרום לאי ספיקת כליות חריפה בכל אחד מהמנגנונים הבאים פרט לאחד. באיזה מנגנון ניתוח מעקפים <u>לא גורם</u> לאי ספיקת כליות חריפה?

א. תהליך אינפלמטורי על ידי אקטיבציה של לויקוציטים
ב. נפרופתיה פיגמנטרית
ג. תהליך אטרו-אמבולי
ד. טרומבוזיס של הוריד הרנלי